

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle V.3	Bezeichnung des Dokumentes: Festlegungen/Standard zur Umsetzung der Maßnahmen der „Ersten Hilfe“ und personenbezogener Notfallsituationen	

I. Definition „Erste Hilfe“

Unter „Erster Hilfe“ versteht man alle Maßnahmen, die bei Unfällen, Erkrankungen oder Vergiftungen bis zum Eintreffen eines Arztes oder des Rettungsdienstes erforderlich sind damit sich der Gesundheitszustand des Betroffenen nicht weiter verschlechtert.

II. Festlegungen für unseren Pflegedienst

- Im Rahmen der Gesamtmaßnahmen der hauswirtschaftlichen und pflegerischen Versorgung können Situationen eintreten die Maßnahmen der Ersten Hilfe als zur Lebensrettung notwendige Handlungen voraussetzen.
- Betreten der Wohnung bei übergebenen Schlüsseln: mit dem übergebenen Schlüssel (siehe Schlüsselstandard) wird die Wohnungstür geöffnet, der Patient / Pflegebedürftige wird angesprochen eine für ihn nicht typische Situation liegt vor.
- Betreten der Wohnung ohne vorhanden sein übergebener Schlüssel: nachdem die Wohnungstür auch nach wiederholtem Klopfen, Klingeln etc. nicht geöffnet wird, vergewissern ob Besuchstermin tatsächlich zu dieser Zeit durchzuführen war (Dienst – und Tourenplan), wenn ja feststellen ob Patient/Pflegebedürftiger verschlafen hat, bei anderen Dritten auswärts schläft oder sich aufhält bzw. andere Gründe vorliegen, die nicht mit einer Notsituation in Verbindung stehen. Die PDL ist sofort zu informieren, die weitere Vorgehensweise ist abzustimmen. Bei Gefahr im Verzug (besondere medizinische Diagnosen wie insulinpflichtige Patienten, schwere Herz- und Kreislauferkrankungen etc.) sind sofort die Polizei, der Notarzt und der Schlüsseldienst zu informieren.
- In jedem Fall hat die Mitarbeiterin unseres Pflegedienstes bei Dienstantritt im häuslichen Bereich des Patienten/Pflegebedürftigen die Vitalfunktionen zu überprüfen und wenn gefordert in der Pflegedokumentation auszuweisen.
- In jedem Fall ist bei unübersichtlichen Situationen der Patient/Pflegebedürftige sofort aus den Gefahrenzonen zu retten um weiteren Schaden abzuwenden.
- Liegen im Einzelfall erhebliche Dysfunktionen der körperlichen und geistigen Lebensumstände des Patienten/Pflegebedürftigen vor, und kann diesem Zustand durch eigenes Handeln nicht abgeholfen werden, so ist umgehend die Rettungsleitstelle unter der Rufnummer: **1 1 2** anzurufen und der Notarzt zu alarmieren.
- Die Meldung an die Rettungsleitstelle soll folgende Mindestinformationen enthalten:

Wo ist der Notfall?

Was ist geschehen?

Wie viel Betroffene/ Verletzte sind zu versorgen?

Welche Verletzungen oder Krankheitszeichen hat der Betroffene?

In jedem Fall ist für etwaige Nachfragen der Rettungsleitstelle der Hörer nicht sofort aufzulegen.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	VerteGF
GF	PDL	01.01.2023		002	I	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle V.3	Bezeichnung des Dokumentes: Festlegungen/Standard zur Umsetzung der Maßnahmen der „Ersten Hilfe“ und personenbezogener Notfallsituationen	

- Bis zum Eintreffen hat sich die Tätigkeit des Mitarbeiters auf folgende Punkte zu konzentrieren
 1. **Prüfung und soweit möglich Sicherung der bewussten Wahrnehmung der Umwelt des Betroffenen**
 2. **Prüfung und soweit möglich Sicherung der Atmung des Betroffenen**
 3. **Prüfung und soweit möglich Sicherung der geordneten Herz – Kreislauffunktionen**
- Grundsätzlich sind die jeweils geltenden und in Lehrgängen dargestellten Handlungen umzusetzen.
- Bei Eintreffen des Notarztes ist dieser über den dann herrschenden IST – Zustand der Vitalfunktionen zu informieren, die eigenen Handlungen bisher sind darzustellen.
- Werden Patienten durch Pflegehilfskräfte aufgefunden so besteht die Pflicht bei Notfällen die nächstverfügbare Pflegefachkraft zu informieren.
- Grundsätzlich ist nach der Notfallübersicht vorzugehen (siehe Anlage), stelle fest um welche Art von Notfall es sich handelt und setze die hier festgelegten Maßnahmen um!
- Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen durch den Mitarbeiter unseres Pflegedienstes informiert dieser sofort die PDL über den Vorfall.
- Innerhalb des Pflegeberichtes erfolgt eine Dokumentation.
- Über die Maßnahmen der Lebensrettung erfolgt ein Aushang als Notfallcheckliste.

III. Weiter – und Fortbildung

Jeder Mitarbeiter unseres Pflegedienstes hat sich die jeweils aktuellsten Handlungen der „Ersten Hilfe“ und der „ Lebensrettenden Maßnahmen“ einzuprägen und anzueignen. Im Rahmen der Fortbildungen werden auch „Erste Hilfe“ Lehrgänge mit berücksichtigt und vorgesehen, der freiwillige Besuch von Lehrgängen zur Auffrischung der Tätigkeiten der „Ersten Hilfe“ ist ausdrücklich erwünscht und sollte in Abständen wiederholt werden.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	VerteGF
GF	PDL	01.01.2023		002	2	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle V.3	Bezeichnung des Dokumentes: Festlegungen/Standard zur Umsetzung der Maßnahmen der „Ersten Hilfe“ und personenbezogener Notfallsituationen	

Notfallübersicht

Notfall: Bezeichnung von schweren Verletzungen in Folge von Unfällen, einer Vergiftung oder einer lebensbedrohliche Erkrankung dabei kommt es zu einer Störung von Bewusstsein, Atmung oder Kreislauf, mit der Folge einer Minderversorgung des Gehirns mit Sauerstoff

Störungen der Atmung

Symptome: angestrenzte Atmung, schwache Atmung, Atemgeräusche, Veränderung der Hautfarbe
Asthmaanfall: zunehmende Atemnot, keuchende, pfeifende Atemgeräusche, Blaufärbung der Lippen bzw. des Gesichts, Angst, Unruhe, Erstickungssituation **Maßnahmen:** keine Atmung-Wiederbelebungsmaßnahmen, auf Lebenszeichen achten, Puls kontrollieren, Notarzt informieren
Atmung vorhanden möglichst umgehend in die stabile Seitenlage bringen, Notarzt informieren, Oberkörperhochlagerung,

Störung des Herz-Kreislauf-Systems

Symptome: Engegefühl in der Brust, Schmerzen im Brust- und Bauchraum, unregelmäßige, verlangsamte oder beschleunigte Herztätigkeit, Veränderung der Hautfarbe (Blässe, Blau- oder Graufärbung) **Handlungen:** ansprechbar-Fragen zur Person, Fragen zur örtlichen Orientierung, Fragen zum Tathergang, nicht ansprechbar-Wiederbelebungsmaßnahmen, auf Lebenszeichen achten, Puls kontrollieren, möglichst umgehend in die stabile Seitenlage bringen, bei starken Blutungen Druckverband anlegen

Störungen des Bewusstseins

Ohnmacht (kurz andauernde Bewusstlosigkeit durch plötzlichen Sauerstoffmangel im Gehirn) oder **Koma** (schwerster Grad einer Bewusstseinsstörung) **Ursachen:** Schlaganfall, Stoffwechselstörungen, Vergiftung, Krampfanfälle, Gewalteinwirkungen auf den Kopf, Unterkühlung, Hitzeeinwirkung **Symptome:** keine Reaktion auf lautes Ansprechen oder mechanische Reize, schlaffe Muskulatur (Ausnahme bei Krämpfen), Husten- und Schluckreflexe können nicht ausgelöst werden (Gefahr des Eindringen von Erbrochenem) **Maßnahmen:** Atemkontrolle, bei spontaner Atmung den Betroffenen in die stabile Seitenlage bringen, Kontrolle von Puls und Atmung in kurzen Abständen, bei Atemstillstand ist eine Atemspende notwendig, Notarzt verständigen

Schock

Definition: akutes Versagen des Kreislaufs im Zusammenhang mit Blutdruckabfall und Beeinträchtigung des gesamten Organismus **Ursachen:** Blutverluste (nach innen oder außen), Wasser- oder Salzverluste (nach Erbrechen oder Durchfällen), Minderung der Herzleistung, Angst, Schmerz, Schreck, plötzliche Kälte- oder Wärmereize, Gifte **Symptome:** Blässe, Frösteln, Unruhe, Angst, schneller, schwacher Puls, kalter Schweiß, Teilnahmslosigkeit, Apathie **Maßnahmen:** Notarzt verständigen, wenn notwendig Blutstillung durchführen, Schock-Lage (Rückenlage, hochlagern der Beine mindestens 30 °), Wärmeverlust vermeiden, Betroffenen beruhigen, Puls- und Atemkontrolle, Blutdruckmessung

Exsikkose

Definition: akute Austrocknung **Ursachen:** starkes Erbrechen, starker Durchfall, Blutverluste, Fieber und Schwitzen, Überdosierung harntreibender Medikamente und Abführmittel, zu geringe Flüssigkeitszufuhr **Symptome:** trockene Haut und Schleimhäute, verminderte Hautspannung, eingeschränkte Harnproduktion, Durst, eingeschränktes Bewusstsein bis hin zur Bewusstlosigkeit, Verwirrtheit, schneller Puls **Maßnahmen:** Flüssigkeitszufuhr bei wenig beeinträchtigten, bewussteinaklen Betroffenen ohne Kreislaufprobleme, Übelkeit und Erbrechen, in schwerwiegenden Fällen Benachrichtigung eines Notarztes (Infusionslösung), Kontrolle von Puls, Atmung und Blutdruck

Schlaganfall= Apoplex , Hirnschlag, Insult, Stroke

Definition: gehört zu den akuten zerebralen (das Gehirn betreffenden) Durchblutungsstörungen **Ursache:** ist die Folge einer plötzlichen Sauerstoffmangelversorgung eines bestimmten Gehirnbereiches, schwerste Mangel durchblutung des Gehirns **Symptome und Folgen:** Gefühllosigkeit und Taubheit an den unterschiedlichsten Körperregionen, Schwäche, Lähmungserscheinungen besonders halbseitig, plötzliche Sehschwäche oder Sehstörungen, Hörverlust, erschwertes Sprechen (z.B. Wortsalat, Silbenverdrehungen, Sprachverlust oder/und Verständnisstörungen wie falsches Befolgen von Anweisungen, Benommenheit, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen oder Koordinationsschwäche, Verwirrung, Erregtheit, plötzliche und starke Kopfschmerzen, plötzliche Übelkeit, Fieber, Schläfrigkeit, epileptische Anfälle **Maßnahmen:** Sicherung lebenswichtiger Funktionen, Oberkörperhochlagerung, stabile Seitenlage bei Bewusstlosigkeit, Notruf

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	VerteGF
GF	PDL	01.01.2023		002	3	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle V.3	Bezeichnung des Dokumentes: Festlegungen/Standard zur Umsetzung der Maßnahmen der „Ersten Hilfe“ und personenbezogener Notfallsituationen	

Vergiftungen	
Ursachen: Medikamente, Alkohol, verdorbene Nahrungsmittel, Gifte Symptome: je nach Art der Vergiftung Kreislaufschock, Bewusstseinsstrübung bis zum Koma, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Atemstörungen bis hin zur Atemlähmung, Hautveränderungen, Unterkühlung, Krämpfe Maßnahmen: Atem-, Puls- und Blutdruckkontrolle, bei Atemstillstand Atemspende, evtl. Schock bekämpfen, Verständigung des Notarztes, evtl. Auslösen von Erbrechen (z.B. bei Aufnahme von Medikamenten über den Magen-Darm-Trakt mit lauwarmem Salzwasser, nicht bei Säuren oder Laugen), leere Tablettenpackungen, Essensreste, Erbrochenes aufbewahren	
Verätzungen	
Ursachen: Verätzungen sind Gewebsschädigungen und -zerstörungen die durch Säuren und Laugen hervorgerufen werden Symptome: heftige Schmerzen im Bereich der Verätzung, Rötungen der Haut bis tiefe Verletzungen, Schockzeichen Maßnahmen: Eigenschutz beachten, Entfernung von benetztem Gewebe, ausgiebiges Spülen von betroffener Haut bzw. der Augen, Abdecken mit sterilem Material, bei Verätzungen des Verdauungstraktes - kein Erbrechen herbeiführen! Kontrolle lebenswichtiger Funktionen, Notarzt informieren.	
Verbrennungen	
Ursachen: entstehen durch große Wärmeeinwirkung, aufgrund großem Flüssigkeitsverlustes entsteht Schockgefahr Symptome: Schmerz, Hautrötung, Blasenbildung, tiefergehende Gewebsschädigung, Nekrosen Maßnahmen: Eigenschutz, Entfernung des Geschädigten aus dem Gefahrenherd., löschen der Kleiderbrände, rasches Entfernen der Kleidung, festklebende Stoffe umschneiden, nicht abreißen, kühlen mit handwarmen Wasser, Kontrolle lebenswichtiger Funktionen, Notarzt informieren, keimfreies Abdecken der Wunden, keine Anwendung von Hausmitteln (Mehl, Salben, Puder)	
Unterkühlungen	
Ursachen: starkes nachhaltiges Einwirken von Kälte auf die Körperoberfläche Symptome: unüberwindliches Schlafbedürfnis, Teilnahmslosigkeit, Verlangsamung von Puls und Atmung, Absinken der Körpertemperatur, Bewusstlosigkeit Maßnahmen: Kontrolle lebenswichtiger Funktionen, Notarzt informieren, Unterkühlten an einen geschützten Ort bringen, nicht überwärmen, nasse Kleidung entfernen, Restwärme erhalten, in Decken hüllen, völlige Ruhelage, Unterkühlten nicht aktiv und passiv bewegen	
Sturz	
Ursachen: nicht beabsichtigtes zum Liegen kommen auf einer unteren Ebene, Ursachen können intrinsisch und extrinsisch sein Symptome: der Verletzte wird durch uns aufgefunden bzw. berichtet von einem Sturz, bei Knochenbrüchen – abnorme Lage und Beweglichkeit, Schonhaltungen, Schmerzen, bei Wirbelsäulenverletzungen – Schmerzen im Beckenbereich, Gefühlslosigkeit, Bewegungsunfähigkeit Maßnahmen: der Verletzte ist anzusprechen, die Vitalzeichen sind zu erheben, lebensrettende Maßnahmen sind umzusetzen, bei Notwendigkeit sofort den Notarzt verständigen, Ruhigstellung, bei Wirbelsäulenverletzung den Verletzten nicht bewegen!	
Hyperglykämie (Überzuckerung)	
Ursachen: Infekte wie Grippe und Magen- Darm- Erkrankungen, schwere Diät- und Behandlungsfehler (z.B. Vergessen einer Insulindosis) bei Werten über 250 mg/dl (13,875 mmol/l), Entwicklung einer Blutzuckerentgleisung innerhalb von einigen Stunden Symptome: Durstgefühl, verstärktes Urinieren, Müdigkeit Diabetisches Koma: = schwere Stoffwechselentgleisung Symptome: extreme Müdig- und Mattigkeit starke Austrocknung Hautfalten bleiben stehen), Brechreiz und Erbrechen, Bauchschmerzen, Bewusstseinsstörungen, Azetongeruch (wie Nagellackentferner) in der Atemluft Maßnahmen: Kontrolle lebenswichtiger Funktionen, Notarzt informieren,	
Hypoglykämie (Unterzuckerung)	
Ursachen: bei Werten unter 50 mg/dl (2,775 mmol/l), häufigste Nebenwirkung bei der Behandlung des Diabetes mellitus mit Insulin und blutzuckersenkenden Tabletten, kann lebensbedrohlich sein, zu niedrige Nahrungs- und Zuckermenge bei gleichbleibender Insulin- und Tablettendosis, zu großer Spritz- Ess- Abstand Symptome: Zittern, Unruhe, Hungergefühl, kalter Schweiß, Schwächegefühl, starkes Herzklopfen, taubes Gefühl/ Kribbeln an Mund, Beinen und Händen, Atem- und Kreislaufstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit, Sehstörungen, Bewusstseinsstörungen, Krämpfe, Bewusstlosigkeit Maßnahmen: zuckerhaltige Säfte, Traubenzucker bereithalten, Notarzt informieren, Lebensrettung umsetzen	

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	VerteGF
GF	PDL	01.01.2023		002	4	Verw./MA